8.8.2. 면역저하 환자 관리

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.07.04.	최 종 검 토 일	2025.07.04.
담 당 부 서	혈액내과				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 8.8 감염성질환 및 면역저하 환자관리 JCI Standard 7th Edition: PCI.1~15

제1조 (목적)

1. 면역저하 환자의 감염발생 위험을 최소화하기 위해 감염성질환의 유입을 차단하고 면역저하 환자를 보호하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 면역저하 환자: 선천적 혹은 후천적, 일시적 혹은 지속적으로 숙주의 반응에 장애가 생겨 감염위험도가 높은 환자(암 또는 AIDS, 이식 환자 등)

제3조 (절차)

1. 감염위험성에 따른 보호격리 대상
   1) 조혈모세포 이식환자로서 감염위험이 있는 경우
   2) ANC(Absolute Neutrophil Count) 수치가 500/μl이하인 경우로서 감염의 위험이 있다고 판단하는 경우
   3) 조혈모세포이식 등 이식환자에서 Grade II 이상의 급성 이식편대 숙주질환(GVHD)이 발생한 경우
   4) 후천성면역결핍증(AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome) 환자 등

2. 격리기간: 보험인정기준에 준한다.
   1) ANC가 3일간 계속하여 500/μl이상 또는 감염의 위험이 소실될 때까지
   2) Grade II 이상의 급성 GVHD가 Grade I으로 호전될 때
   3) 면역기능이 현저히 회복될 때까지

3. 보호격리실
   1) 배치
      (1) 조혈모세포이식환자를 위해 보호격리 시설을 운영한다.
      (2) 조혈모세포이식환자는 HEPA Filter를 통해 공기가 공급되는 무균병실을 사용한다.
      (3) 면역저하환자는 HEPA Filter가 설치된 병실이나 1인실을 사용한다.
   2) 보호격리실 제공이 불가능하거나 기타 필요한 경우 이동식 HEPA Filter를 설치할 수 있다.
   3) 시설 설치 기준 및 관리
      (1) 설치 기준

① 지름 0.3㎛이상의 먼지를 99.97% 제거하는 HEPA Filter를 통해 공기를 공급한다
② 시간당 12회이상 공기를 통풍시키는 환기장치를 사용하고, 필요 시 비상환기 장치를 준비해 둔다.
③ 외부의 공기가 유입되지 않도록 창문이나 문틈이 잘 봉합되어 있어야 하며, 출입문은 저절로 닫히도록 한다.

(2) 양압유지를 위한 관리
① 보호격리실은 양압(복도 등 외부에 비해 2.5Pa 이상 높은 기압)을 유지한다. (차압계 및 Relief damper로 양압 유지 여부를 확인한다.)
② 양압시설이 있는 부서는 다음과 같이 점검을 시행한다.
a. 보호격리실 사용을 시작할 때 점검한다.
b. 보호격리실을 사용하고 있는 경우 매일 점검한다.
c. 보호격리실을 사용하지 않는 경우에는 최소 1회/월 점검한다.
③ 양압시설 문제 발생 시 시설관리팀 등 관련부서에 연락하여 해결한다.
④ 무균병동의 공조시설 유지보수는 별도의 관리지침을 따른다.

(3) 준비물품
① 환자에게 사용할 의료기기 또는 물품은 필요시 환자 별도로 소독된 장비(BP기계 등)를 사용한다.
② 보호격리실 출입 시 필요한 물품(마스크, 멸균가운, 멸균장갑, 모자 등)을 병실 밖에 준비해 놓는다.

(4) 환경 관리
① 격리 진행 전 환경소독제를 이용하여 병실 내 집기를 포함한 모든 표면을 닦는다.
② 주 2회 환경소독제를 이용하여 집기, 비품을 청소하고, 직물류를 교체한다.
③ 병실과 복도에 카페트를 사용하지 않는다.
④ 장난감은 세척과 소독이 가능한 재질로 소독하여 개별로 사용하고 다른 환자와 공유하지 않는다.
⑤ 꽃이나 화분은 허용하지 않는다.

4. 환자관리
1) 보호격리가 결정되면 격리실 사용 신청을 한다.
2) 감염관리지침에 따른 손위생을 준수한다.
3) 처방에 따라 피부, 구강 및 회음부 관리를 시행한다.
4) 환자와의 신체적 접촉을 최소화하고 부득이하게 접촉해야 하는 경우 손위생을 시행한 후 접촉한다.
5) 침습과정은 최소화하며, 침습 기구(예: 카테터, 튜브)는 의학적 상태가 회복되는 즉시 제거한다. 편의를 위해 침습 기구를 사용하지는 않는다.
6) 환자 간호 및 면회 시 감염증상(발열, 호흡기 증상 등)이 없어야 하며, 손위생 등의 무균법과 위생을 철저히 준수하여야 한다.
7) 감염증상(발열, 호흡기 증상 등)이 있는 경우 해당 진료참여를 제한하고, 부득이하게 진료에 참여해야 하는 경우 마스크를 착용한다.
8) 발열 등 감염증상을 모니터링하며 필요 시 검사를 시행한다.

9) 보호자는 1인까지만 상주할 수 있으며, 방문객의 출입을 제한한다.

5. 환자 및 보호자 대상으로 보호격리 관련 준수사항 교육
   1) 손위생 수행방법, 시기, 손소독제를 설명한다.
   2) 구강위생 관리방법(소독액, 가글, 칫솔관리 등)을 설명한다.
   3) 항문주위 피부간호, 청결유지 방법, 변비예방을 설명한다.
   4) 식사(음료, 간식 포함) 시 주의사항을 설명한다.
   5) 기타 면역저하환자 주의사항을 교육한다.

6. 환자에게 사용한 의료기기 또는 물품 관리
   1) 환자에게 사용한 장비, 기구 및 장치의 관리는 표준주의에 따른다.

7. 직원 간 정보공유 방법
   1) 보호격리를 적용하는 경우 병실 문앞에 '보호격리', '조혈모세포이식' 등의 표식을 부착한다.

8. 환자 이송방법
   1) 면역저하환자는 이동을 최소화하며, 검사실이나 외부이동 시에는 개인보호장구(모자, 마스크, 멸균가운 등)을 착용한다.
   2) 이송이 필요한 경우 이송의뢰지에 '보호격리' 환자임을 표시하고, 직원간 의사소통한다.
   3) 보호격리를 받는 환자가 보호격리실을 떠나 의료기관 내 공사 중인 구역을 지나갈 경우 N95 마스크를 착용한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)
1. 이 내규는 2025년 7월 4일부터 시행한다.

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)